TEMARIO ESPECÍFICO - EDUCACIÓN SOCIAL (A2.2018)

# TEMA 8

## El Desarrollo en la Primera Infancia: Lenguaje y Comunicación, Desarrollo Social, Motor, Afectivo, el Pensamiento Percepto-Motor. Implicaciones Socioeducativas. Educación para la Promoción del Desarrollo Personal y Social en esta Etapa. Problemas y Dificultades más Frecuentes y su Respuesta Socioeducativa. Acompañamiento Socioeducativo a las Familias y al Profesorado

**Cuerpo:** Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

**Especialidad:** Educación Social (A2.2018)

**Bloque:** Materias Específicas

**Tema Oficial:** 8

**Normativa Clave:** Ley Orgánica 2/2006 (LOE) modificada por Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE); Ley 17/2007 (LEA); Decreto 100/2023 de Educación Infantil en Andalucía; Ley 1/2023, de 16 de febrero, de Atención Temprana de Andalucía; Ley 4/2021 de Infancia de Andalucía.

**Autores y Referentes:** Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, John Bowlby, Mary Ainsworth, Henri Wallon, Noam Chomsky, Donald Winnicott, Urie Bronfenbrenner.

# ÍNDICE GENERAL DEL TEMA 8

**1. Introducción y justificación en la Educación Social**

**2. El desarrollo en la primera infancia (0 a 6 años): Dimensiones evolutivas**

2.1. Desarrollo del lenguaje y la comunicación: De la etapa prelingüística a la competencia comunicativa

2.2. Desarrollo motor y percepto-motor: Leyes madurativas, esquema corporal y psicomotricidad

2.3. Desarrollo afectivo y teoría del apego (Bowlby y Ainsworth)

2.4. El pensamiento percepto-motor y cognitivo: Del estadio sensoriomotor al preoperacional (Piaget)

2.5. Desarrollo social: Socialización primaria, del juego individual al juego simbólico y compartido

**3. Implicaciones socioeducativas y promoción del desarrollo personal y social**

3.1. La educación infantil como entorno preventivo y compensador de desigualdades

3.2. El juego como motor del desarrollo global y herramienta pedagógica

3.3. Creación de entornos afectivos seguros, estimulantes e inclusivos

**4. Problemas y dificultades más frecuentes en la primera infancia y su respuesta socioeducativa**

4.1. Trastornos y retrasos en la adquisición del lenguaje y la comunicación (TEL/TDL, dislalias, mutismo)

4.2. Dificultades en la vinculación afectiva: Apego inseguro y desorganizado

4.3. Desregulación emocional y conductual: Rabietas, agresividad y hábitos cotidianos (sueño, esfínteres)

4.4. Señales de alarma temprana en el neurodesarrollo (TEA, retraso madurativo)

4.5. Situaciones de riesgo, negligencia y maltrato infantil precoz

**5. Acompañamiento socioeducativo a las familias y al profesorado**

5.1. El marco andaluz: Ley 1/2023 de Atención Temprana y coordinación con los CAIT

5.2. Asesoramiento a las familias en parentalidad positiva y pautas de crianza respetuosa

5.3. Acompañamiento técnico al profesorado de Educación Infantil y coordinación con el EOE

5.4. Trabajo en red comunitario: Servicios Sociales, Pediatría y recursos del entorno

**6. Conclusión y rol del educador/a social**

**7. Anexo: Mapa conceptual y tabla sinóptica del Tema 8**

# 1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN SOCIAL

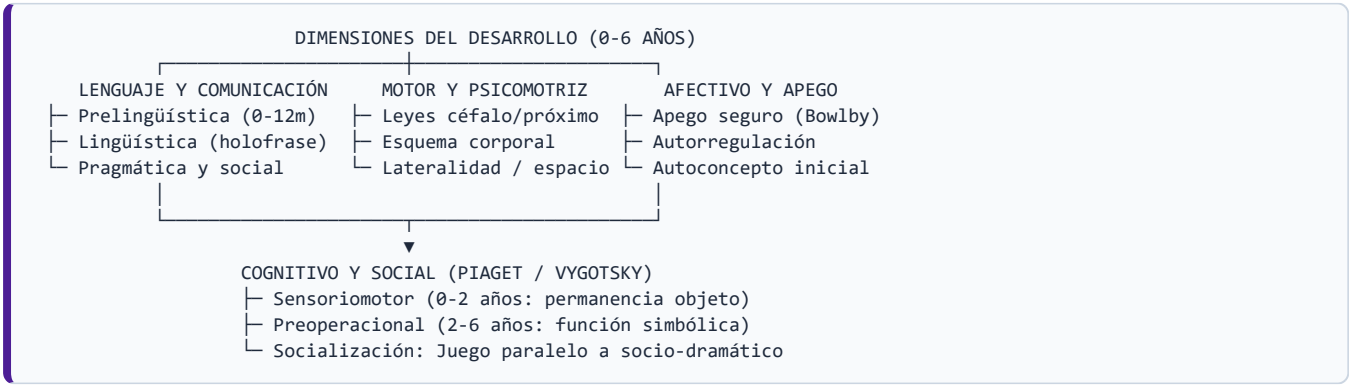
La **primera infancia (de los 0 a los 6 años)** constituye la etapa más crítica, plástica y determinante en la biografía del ser humano. En este periodo se asientan las bases de la arquitectura cerebral, la vinculación afectiva, la adquisición del lenguaje, la estructuración motriz y los patrones básicos de relación social.

Las investigaciones en neurociencia y psicología del desarrollo (Piaget, Vygotsky, Bowlby, Bruner) evidencian que los primeros años de vida definen las trayectorias de aprendizaje y salud emocional futuras. Cuando un menor crece en un entorno de apego seguro y estimulación adecuada, desarrolla resiliencia y competencias adaptativas; por el contrario, la exposición a situaciones de vulnerabilidad, pobreza extrema, estrés tóxico o negligencia parental puede condicionar irreversiblemente su desarrollo neurobiológico y social.

Para el **Educador y la Educadora Social**, esta etapa representa el **espacio por excelencia de la prevención primaria y secundaria**. En el marco de la **Ley 1/2023 de Atención Temprana de Andalucía** y de la **Ley 4/2021 de Infancia**, el educador social despliega una intervención multidimensional: detecta precozmente señales de alarma, acompaña a las familias vulnerables fomentando la parentalidad positiva, colabora con los equipos docentes de Educación Infantil y teje redes de coordinación con los servicios sanitarios y comunitarios para blindar el bienestar infantil desde el origen de la vida.

# 2. EL DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA (0 A 6 AÑOS): DIMENSIONES EVOLUTIVAS

El desarrollo infantil es un proceso global, unitario y continuo, condicionado por la interacción bidireccional entre la maduración biológica y el entorno sociocultural (modelo bioecológico de Bronfenbrenner).




## 2.1. Desarrollo del lenguaje y la comunicación

- **Etapa prelingüística (0 a 12 meses):**
  - Comunicación a través del llanto, sonrisa social (2 meses), balbuceo y laleo (6 meses).
  - Aparición de **gestos protodeclarativos y protoimperativos** (9-10 meses) y protoconversaciones basadas en la sintonía afectiva (Bruner: Sistema de Apoyo a la Adquisición del Lenguaje - LASS).
- **Etapa lingüística (a partir de los 12 meses):**
  - **Holofrase (12-18 meses):** Una sola palabra condensa el significado de una oración completa ("*agua*" = "*dame agua*").
  - **Habla telegráfica (18-24 meses):** Combinación de dos palabras ("*nene coche*"). Explosión léxica (vocabulario de más de 50 palabras).

- **Desarrollo morfosintáctico y pragmático (3 a 6 años):** Construcción de oraciones complejas, superación de sobrerregulaciones gramaticales ("*hacido*" por "*hecho*") y uso social del lenguaje para negociar, narrar y expresar emociones. Vygotsky destaca el **lenguaje egocéntrico** como herramienta de autorregulación del pensamiento que culminará en el lenguaje interiorizado.

### 2.2. Desarrollo motor y percepto-motor

Sigue dos leyes psicofisiológicas universales:

1. **Ley céfalo-caudal:** El control madurativo desciende de la cabeza a los pies (control cefálico, sedestación, bipedestación y marcha).
2. **Ley próximo-distal:** El control progresa desde el eje central del cuerpo hacia las extremidades (hombro, brazo, muñeca, pinza digital fina).

Aportaciones de la psicomotricidad (Wallon, Le Boulch, Picq y Vayer):

- **Esquema corporal:** Representación mental que el niño construye de su propio cuerpo en reposo y movimiento a partir de sensaciones propioceptivas y visuales.
- **Tono muscular y control postural:** Base física de la atención y la emoción (el "diálogo tónico" de Wallon como primer canal de apego).
- **Lateralidad:** Definición funcional del predominio de un hemisferio cerebral (diestro o zurdo) consolidada hacia los 4-5 años.
- **Estructuración espacio-temporal:** Adquisición paulatina de nociones de orientación espacial (arriba/abajo, dentro/fuera) y temporal (antes/después, día/noche).

### 2.3. Desarrollo afectivo y teoría del apego

**John Bowlby** postuló que los seres humanos nacen con una necesidad biológica innata de establecer vínculos de apego con cuidadores principales para asegurar su supervivencia y protección:

- **Fases del apego:** Preatribución (0-2 meses), formación del apego (2-7 meses), apego bien definido con ansiedad por separación (7-24 meses) y relaciones de reciprocidad (a partir de los 2 años).
- **Tipologías de apego de Mary Ainsworth (Situación del Extraño):**
  - **Apego Seguro:** El niño explora con confianza en presencia de la figura de apego, muestra malestar en su ausencia y se consuela rápidamente a su regreso. Asociado a cuidadores empáticos y sensibles.
  - **Apego Inseguro-Evitativo:** Aparenta indiferencia ante la marcha o regreso de la madre; sufre estrés fisiológico encubierto ante cuidadores rechazantes o fríos.
  - **Apego Inseguro-Ambivalente/Resistente:** Angustia extrema ante la separación y cólera o resistencia al consuelo en el reencuentro. Asociado a pautas parentales impredecibles e inconsistentes.
  - **Apego Desorganizado (Main y Solomon):** Conductas contradictorias, paralización y miedo ante la figura de apego. Es el predictor más grave de trauma y psicopatología, característico de contextos de negligencia severa o maltrato.

### 2.4. El pensamiento percepto-motor y cognitivo (Jean Piaget)

- **Estadio Sensoriomotor (0 a 2 años):** Inteligencia práctica basada en acciones motoras y percepciones sensoriales. Hito capital: la adquisición de la **permanencia del objeto** (comprender que las cosas existen aunque no se vean, hacia los 8-9 meses).
- **Estadio Preoperacional (2 a 6 años):** Nacimiento de la **función simbólica** (el lenguaje, la imitación diferida, el dibujo y el juego simbólico).

- **Rasgos del pensamiento infantil:** Egocentrismo cognitivo (dificultad para adoptar la perspectiva del otro), centración (fijarse en un solo rasgo perceptivo), irreversibilidad (incapacidad de deshacer mentalmente una secuencia), animismo (atribuir vida a objetos inertes) y sincretismo.

### 2.5. Desarrollo social y evolución del juego

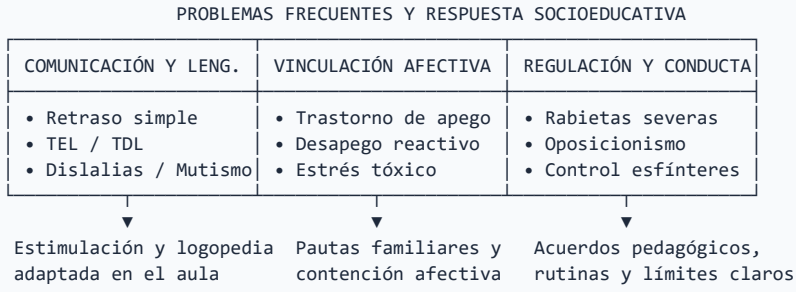
El juego es la actividad rectora de la infancia:

- **Juego sensoriomotor / funcional (0-2 años):** Repetición de movimientos placenteros con el propio cuerpo o juguetes.
- **Juego simbólico / ficción ("hacer como si", 2-6 años):** Representación de roles adultos, canalización de miedos y recreación de vivencias cotidianas.
- **Evolución relacional:** Transición del juego en solitario al juego paralelo (jugar al lado sin interacción), asociativo y, finalmente, cooperativo estructurado con normas sencillas.

## 3. IMPLICACIONES SOCIOEDUCATIVAS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

1. **La Escuela Infantil como espacio de compensación temprana:** El primer y segundo ciclo de Educación Infantil (0-3 y 3-6 años) actúan como potentes igualadores de oportunidades sociales. Una escolarización de calidad neutraliza los déficits de estimulación de hogares desfavorecidos.
2. **Ambientes afectivos y seguros:** El docente y el educador social deben constituir **figuras de apego secundarias**, ofreciendo contención emocional, límites claros y un clima de aceptación incondicional.
3. **El juego como metodología privilegiada:** Rechazo a la academización precoz; el aprendizaje en la infancia se consolida a través de la exploración multisensorial, la experimentación libre y el juego dramático.

## 4. PROBLEMAS Y DIFICULTADES MÁS FRECUENTES EN LA PRIMERA INFANCIA Y SU RESPUESTA SOCIOEDUCATIVA




### 4.1. Retrasos en la comunicación y el lenguaje

- **Retraso simple del lenguaje (RSL):** Desfase cronológico global pero evolutivamente normalizado, reversible con estimulación sociofamiliar.
- **Trastorno Específico del Lenguaje (TEL / Trastorno del Desarrollo del Lenguaje - TDL):** Alteración persistente en la comprensión y/o expresión no explicable por déficit sensorial ni intelectual.
- **Mutismo selectivo:** Inhibición selectiva del habla en la escuela manteniendo comunicación en el hogar; de base ansiosa y relacional.

### 4.2. Dificultades en la vinculación y autorregulación emocional

- **Trastornos del apego:** Incapacidad para establecer vínculos significativos o vinculación indiscriminada con extraños ante historiales de abandono o negligencia.
- **Conductas disruptivas y rabietas desreguladas:** Manifestaciones de inmadurez frontal o de estilos parentales inconsistentes o sobreprotectores.
- **Trastornos en las rutinas biológicas:** Enuresis/encopresis secundaria, trastornos del sueño o rechazo alimentario, habitualmente reactivos a situaciones de estrés familiar (divorcios conflictivos, nacimiento de hermanos, violencia de género).

### 4.3. Señales de alarma temprana en el neurodesarrollo

- **Trastorno del Espectro del Autismo (TEA):** Ausencia de contacto ocular, falta de respuesta al nombre, retraso en gestos comunicativos, conductas estereotipadas o hipersensibilidad sensorial observable antes de los 3 años.
- **Retraso madurativo global:** Desfase significativo en dos o más áreas del desarrollo psicomotor y cognitivo.

### 4.4. Situaciones de riesgo, desatención y maltrato infantil precoz

Indicadores físicos (lesiones no accidentales, desnutrición, falta de higiene) o conductuales (hipervigilancia, retraimiento extremo, terror al contacto físico) que obligan a activar de inmediato el **protocolo SIMIA** de la Junta de Andalucía.

## 5. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO A LAS FAMILIAS Y AL PROFESORADO

### 5.1. Marco normativo andaluz: Ley 1/2023 de Atención Temprana

La **Ley 1/2023, de 16 de febrero, de Atención Temprana de Andalucía** garantiza un modelo público, universal, gratuito y de calidad para menores de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo o en riesgo de padecerlos:

- Intervención interdisciplinar articulada a través de los **Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT)**.
- Coordinación obligatoria entre el sistema sanitario (Pediatría de Atención Primaria), los Servicios Sociales Comunitarios y el sistema educativo (Educación Infantil y Equipos EOE especializados).

### 5.2. Asesoramiento a las familias en parentalidad positiva

El Educador Social interviene como guía y facilitador del entorno doméstico:

- **Escuelas de Familias de 0 a 6 años:** Talleres sobre rutinas del sueño, alimentación, límites sin gritos ni castigos físicos, y fomento del apego seguro.
- **Intervención domiciliaria:** Acompañamiento en el hogar para modelar pautas de estimulación lúdica, lectura compartida y organización del espacio doméstico en familias vulnerables.
- **Prevención de la sobreexposición digital:** Concienciación sobre los graves efectos de las pantallas en el desarrollo del lenguaje y la atención en menores de 3 años.

### 5.3. Acompañamiento técnico al profesorado de Educación Infantil

- Coordinación de pautas de modificación conductual y refuerzo positivo en el aula.
- Adaptación del periodo de acogida y adaptación escolar en septiembre para prevenir la angustia de separación.
- Diseño de espacios de relajación y rincón de la calma en las aulas.

### 5.4. Coordinación intersectorial en red

El Educador/a Social actúa como bisagra entre la escuela infantil, los servicios de Pediatría, los CAIT y los Servicios Sociales Comunitarios (PRISO), asegurando que ningún menor quede desatendido por falta de coordinación institucional.

## 6. CONCLUSIÓN Y ROL DEL EDUCADOR/A SOCIAL

La primera infancia es la ventana de oportunidad biológica y social más fecunda de la existencia humana. Todo esfuerzo socioeducativo invertido en los primeros seis años de vida tiene un **retorno social incalculable**, previniendo el fracaso escolar, las conductas delictivas y la exclusión futura.

El **Educador y la Educadora Social** ejerce una labor trascendental en esta etapa: despoja a la intervención temprana de sesgos puramente médicos o rehabilitadores para dotarla de una **mirada comunitaria, relacional y familiar**. Cuidar a la infancia en sus primeros años no es solo una responsabilidad de sus progenitores; es el compromiso ético y político de una sociedad democrática que garantiza a todos sus niños y niñas el derecho a un comienzo de vida digno, seguro y estimulante.

## 7. ANEXO: MAPA CONCEPTUAL Y TABLA SINÓPTICA DEL TEMA 8

| Dimensión Evolutiva | Teorías y Autores Clave | Manifestaciones y Dificultades | Intervención Socioeducativa |
|---|---|---|---|
| **Lenguaje y Comunicación** | • Bruner (LASS) • Vygotsky (lenguaje egocéntrico) • Chomsky | • Prelingüística a morfosintáctica.<br>• Retrasos del lenguaje, TEL/TDL, dislalias y mutismo. | Estimulación comunicativa en el aula, lectura dialógica y coordinación con logopedia. |
| **Desarrollo Motor y Perceptivo** | • Leyes céfalo-caudal y próximo-distal.<br>• Wallon • Le Boulch (psicomotricidad). | • Esquema corporal y lateralidad.<br>• Torpeza motriz, dispraxias e inhibición psicomotriz. | Circuitos psicomotrices vivenciados, juego libre y estructuración temporal. |
| **Desarrollo Afectivo y Apego** | • Bowlby (teoría del apego).<br>• Ainsworth (tipologías de apego: seguro, evitativo, ambivalente, desorganizado). | • Angustia de separación.<br>• Trastornos reactivos del apego por negligencia o desamparo. | Figura de apego secundaria en el centro; fomento de parentalidad positiva en familias. |
| **Desarrollo Cognitivo** | • Jean Piaget (sensoriomotor y preoperacional). | • Permanencia de objeto, egocentrismo, centración y función simbólica. | Provocaciones pedagógicas, rincones de juego simbólico y exploración sensorial. |
| **Socialización y Juego** | • De juego paralelo a juego cooperativo compartido. | • Dificultades de interacción, aislamiento social o agresividad. | Dinamización del juego compartido, modelado de turnos y mediación en conflictos. |
| **Marco Autonómico** | • Ley 1/2023 de Atención Temprana de Andalucía • CAIT. | • Retrasos madurativos y TEA.<br>• Factores de riesgo sociobiológico. | Detección precoz en escuela infantil y derivación a Pediatría y CAIT. |
| **Acompañamiento a Familias** | • Parentalidad positiva • Modelo bioecológico de Bronfenbrenner. | • Estrés parental, estilos educativos autoritarios o negligentes. | Escuelas de familias, visitas domiciliarias y prevención de la sobreexposición a pantallas. |
| **Rol del Educador/a Social** | • Instrucciones 17 de septiembre de 2010. | • Vulnerabilidad, maltrato precoz y desprotección (SIMIA). | Agente de prevención primaria, nexo escuela-salud-servicios sociales y apoyo familiar. |